جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : عصمت حسن مصيلحي عطيه
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** العجوزه **العنوان :** العجوزه
رقم البطاقة : 26809292102145 **رقم التليفون :** 01060194247 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 29-09-1968 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: عصمت حسن مصيلحي عطيه
National ID: 26809292102145

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

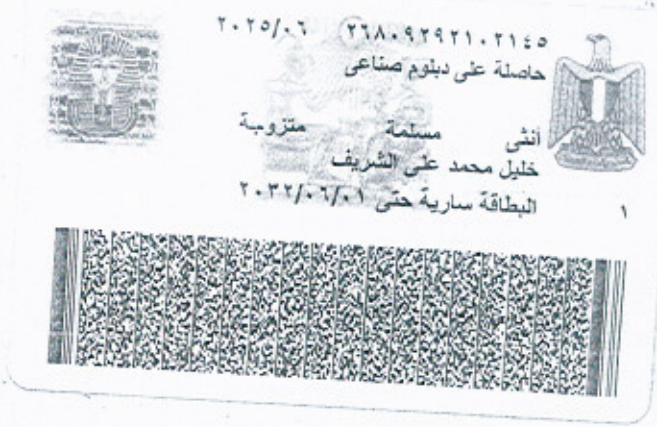
تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Further investigations and imaging**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Dr.
Elia Anis Ishak
M. Sc. Ph. D. Pathology - Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology , USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Dr.
Shady Elia Anis
M. Sc. MD Pathology , Ass. Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow , Mass General Hospital , Harvard , USA
Member , United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : عصمت حسن مصيلحى عطيه
Analysis ID : 716640
Age : 54 Y : 3 M : 1 D
Gender : Female
Referred By Prof. Dr. : محمد شعلان
Clinical Diagnosis : Right breast mass
Nature of Specimen : Right lumpectomy and Axillary lymphadenectomy
Receiving Date : 2023-01-09
Patient ID : 551127

PATHOLOGY REPORT

Gross :

Two containers were received:
1- Right lumpectomy: Two irregluar fibrofatty tissue pieces, the larger measured 6.5x4x3.5 cm, cut section showed firm gritty mass measured 2.5x2x1.5 cm, located 1 cm from the nearest surgical margin.
Smaller fibrofatty tissue piece measured 3x2x1.2 cm, totally submitted.
2- Right axillary lymphadenectomy: Multiple irregular fibrofatty tissue pieces, collectively measured 7x7 cm, entangled 11 nodules, measured up to 1x1 cm.

Microscopic :

1- Sections examined from the specimen received revealed breast tissue showing tumour tissue formed of irregular groups of malignant ductal cells showing moderate nuclear pleomorphism and hyperchromasia. There is moderate attempt at tubular formation.
There is moderate number of mitotic figures.
There is moderate desmoplasia. There is focal tumoral necrosis.
There is peritumoural lymphocytic infiltration 5%.
Lympho- vascular space invasion is present.
Perineural invasion absent.
There is an intraductal component about 5% showing solid and cribriform patterns.
Surgical margins are free. The smaller tissue piece showed fibrofatty tissue with areas of fibroadenosis and fibrocystic changes.
2- Sections examined from the axillary nodes revealed metastatic deposits in 4 out of 11 nodes, with no capsular infiltration.

N ٩١١

DR ELIA ANIS LABS
عمارة رمسيس - بلوك أ - ميدان رمسيس - الدور السادس و السابع
تليفون : ٢٥٧٩٠٩٣٥ - ٢٥٧٤٤٧٤٢ - ٢٥٧٧٣٢٥٣

Name: عصمت حسن مصلحي عطيه **MR. :** 5983	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was diagnosed with bilateral synchronous breast cancer and underwent upfront surgical resection. Following surgery, the patient received adjuvant chemotherapy and was placed on postoperative radiation therapy (PORT) with Arimidex, planned for a duration of seven years beginning in September 2023. An annual evaluation was requested.

At the subsequent visit, the bilateral synchronous breast cancer status remained unchanged, with continued postoperative management. The patient's medication regimen included PAUS (prescribed December 2025), SM (prescribed 10 January 2026), calcium supplementation (ONE ALPHA 1 × 1 × 90), Arimidex, and Zometa 4 mg. No new oncologic interventions were documented.

During the most recent oncology assessment, the patient continued on hormonal therapy with Arimidex, which has been administered for three months as an aromatase inhibitor. The current plan is to maintain ongoing endocrine therapy with Arimidex.

تحريرا في ,

التاريخ :	**19-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : علياء احمد أبو النصر شهاب الدين

يعتمد ,

83128120

يس الجمهورية
ة المرأة المصرية

الست الهى
صحة مصر

MDT FORM 7 / 3 / 2023 G

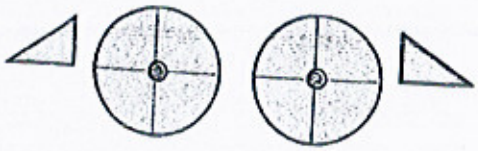
Name	[illegible]	MRN	796 C.C٣
Age	54yrs	ID	٢٧٨٠٩٢٩٠١٠١٤٠
Menopausal status	Natural Menopause 10yrs ago	Phone	٠١١٠٤١٢٧٧٠ ٠١١١٥٥٢٨٩٢٠
NRS SCORE		Marital status	married
BMI		Family history	-ve
CO morbidity	-HTN: on oral anti-hypertensive. -DM: on oral hypoglycemic drug.	REASON OF MDT	

Clinical Data

BX: *Lt. Breast: IDC, with Tubular Features, G. I.
*Rt. Breast: IDC, G. II.

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
*Lt. Breast: strong +ve	strong +ve	-ve (0)	17%
*Rt. Breast: 8/8	8/8	-ve (0)	

R L



Sonomammography:

Mets Workup:
*Bone scan: Free.
*Pelvi. Abd. UIS: Free

TNM

*BRCA1, 2: -ve

Recommendations: Bilateral Synchronous Breast cancer

* Underwent Upfront surgeries: - Lt. Lumpectomy + SLN: pT_2 pN_0
- Rt. Lumpectomy + ALND: pT_2 $pN_{4/11}$
* Refered For: Adjuvant ttt: كيماوي
C.C٣ / C / CV

MDT OUTCOME & PLAN

for 4 AC / 12 Taxol weekly / PORT / A.I
for 7 years

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
SP 7/3/23		[illegible]			

CamScanner الممسوحة ضوئيا بـ

صحة سكان للأشعة والتحاليل
SEHA SCAN & LAB

LHA
LADIES HEALTH ALLIANCE

MRS. ESMAT HASSAN MASLAHI
DATE. 12/12/2022
PROF. LOAY KASSEM
CODE. 184623

FULL FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHIC EXAMINATION OF BOTH BREASTS:

CLINICAL SUMMARY : LT lumpectomy for IDC 1 month ago.

IMPRESSION :

LEFT BREAST: (BIRADS 2= Benign) Postoperative changes.

RIGHT BREAST: (BIRADS 5= Malignant) UOQ malignant mass with pathological axillary LNs.

RECOMMENDATION:- US guided core biopsy.

DETAILED FINDINGS :

TECHNIQUE:
Craniocaudal & mediolateral Oblique views
High Resolution Ultrasound with Elastography & Color Doppler.

LEFT BREAST:
Scattered fibroglandular pattern (ACR B).
Postoperative scarring is seen at the central region.
Complementary US demonstrated no solid lesions. A 6 x 2cm cystic seroma is seen within the scar.
Normal skin/nipple/areolar complex. No pathological axillary lymph nodes.

RIGHT BREAST:
Scattered fibroglandular pattern (ACR B)
A spiculated mass is seen at the UOQ.
Complementary US demonstrated its solid nature measuring10 x 10mm in diameter. No vascularity within.
Normal skin/nipple/areolar complex
Multiple (at least two) level 1 pathological axillary lymph nodes with thick cortices and thinned hila are seen reaching 13mm in size .

Thanks for your Reference,
Dr. Norran Hussein, MD FRCR

S.s

38 Mohi El Din Abo El Ezz St, 4th Floor , Dokki, Cairo, TEL. 02 37 486 100/300/500 , FAX. 02 37 49 33 12, www.sehascan.com

معمل التحاليل الباثولوجية
PATHOLOGY LABORATORY
الدكتور / أحمد الحناوى
أستاذ الباثولوجي بكلية الطب - جامعة القاهرة
زميل جامعة نورث كارولينا - الولايات المتحدة الأمريكية

(Addendum to report number "3N326") 3 N 394

PATHOLOGY REPORT

Name: عصمت حسن مصيلحى عطية

Referred by: أ.د. وسام الشريف **Age:** 54 Y **Sex:** Female

Clinical data: Left breast cancer.

Nature of the specimen: Immunophenotyping of tumor cells.

Date of test requested: 24/11/2022

PROCEDURE: Sections from the paraffin block of tumor tissue were treated with antigen retrieval solution; then treated with monoclonal antibodies against estrogen & progesterone receptors, and Her2-neu antigen using streptavidin biotin peroxidase system; DAB was used as a substrate and chromogen; hematoxylin was used as a counter stain.

RESULTS:

- Section treated for **estrogen receptors** revealed **STRONG POSITIVE** nuclear staining of the tumor cells by the chromogen **(score 3+)**.
- Section treated for **estrogen receptors** revealed **STRONG POSITIVE** nuclear staining of the tumor cells by the chromogen **(score 3+)**.
- Sections treated for **Her2-neu** antigen revealed **NEGATIVE** membranous staining of the tumor cells by the chromogen **(score 0)**.

Signature
Prof. Dr. Ahmed El Hennawy

عنوان المعمل : ١٤ ش العباسى - موقف اتوبيس مدينة الطلبة - العجوزة تليفون: ٣٣٤٥٧٦١١ - ٠١٠٩٦٢٢٦٤٧٤